

הדגמים של מערכות רפואת חירום טרום־אשפוזית

עד סוף המאה העשרים היו שני דגמים עיקריים של מערכות רפואת חירום: הדגם "הצרפתי־גרמני" והדגם "האנגלי־אמריקאי" והם נבדלו זה מזה בהיבטים ייחודיים הנטועים בתפיסות שונות של רפואת חירום ושל רמת הטיפול הניתנת בחירום. כיום יש דגמים נוספים המבוססים על שילוב בין השניים.

הדגם ה"צרפתי־גרמני" מבוסס על רעיון "שהייה וייצוב" (stay and stabilize). המאפיין של דגם זה הוא הבאת בית החולים אל המטופל; דגם זה מתבסס על טיפול של רופאים שיש להם הכשרה נרחבת ועל שימוש בטכנולוגיות מתקדמות כבר במקום האירוע. בדרך כלל דגם זה הוא חלק ממערכת בריאות רחבה. הוא מיושם בעיקר באירופה שבה רפואת החירום היא תחום צעיר יחסית. לפיכך, באירופה רפואת חירום טרום־אשפוזית ניתנת כמעט תמיד על ידי רופאים. לרופאים אלו הסמכות לפעול על פי שיקולים קליניים מורכבים ולטפל במטופלים בזירת האירוע, מה שמוביל לפחות העברות של מטופלים לבתי החולים. במקרים המעטים שבהם המטופלים מפונים לבית החולים, הם בדרך כלל מאושפזים ישירות במחלקה הייעודית בהחלטת הרופא שטיפל בהם ומדלגים על שלב חדר המיון. דגם זה נמצא בשימוש נרחב במדינות כמו גרמניה, צרפת, יוון, מלטה ואוסטריה.

לעומתו, הדגם ה"אנגלי־אמריקאי" מבוסס על רעיון "הוצאה וריצה" (scoop and run). המאפיין של דגם זה הוא איסוף הנפגעים במהירות מזירת האירוע והבאתם בזריזות לבתי החולים עם מיעוט טיפולי חירום רפואיים טרום־אשפוזיים. בדרך כלל דגם זה עובד בשיתוף פעולה עם גורמי בטיחות הציבור כגון משטרה ושירותי כבאות והצלה ופחות עם בתי חולים. המערכות מבוססות בדרך כלל על פראמדיקים וחובשים מאומנים הנותנים סיוע רפואי בפיקוח של רופא או של מערכת הבריאות. במדינות המשתמשות בדגם זה רפואת החירום היא תחום מפותח ומוכר כמומחיות רפואית נפרדת. רוב המטופלים בדגם זה מפונים על ידי צוותי שירות החירום הרפואי הטרם־אשפוזי למחלקות לרפואה דחופה של בתי החולים ומיעוטם ישירות למחלקות אשפוז. מדינות המיישמות דגם זה הן ארצות הברית, קנדה, ניו זילנד, עומאן ואוסטרליה.

מד"א מספק שירות רפואת חירום טרום־אשפוזית המשלב את הדגם ה"צרפתי־גרמני" והדגם ה"אנגלי־אמריקאי" לפי אופי האירוע ומצבו של המטופל. אומנם בבתי החולים בישראל מחלקות רפואת החירום מבוססות היטב: מחלקות טיפול נמרץ ומחלקות טראומה, אך על פי פרטוקולים הקבועים מראש ולפי שיקול דעתם הרפואי של אנשי הצוות יש מקרים שבהם רוב הטיפול ניתן בזירת האירוע טרם הפינוי לבית החולים.

ככל שמואץ תהליך העיור בעולם, מערכות רפואת חירום טרום־אשפוזית צריכות להתקדם כדי להתמודד עם המחלות והפגיעות החמורות המאפיינות את אוכלוסיית הערים. מערכות אלו צריכות להיות גמישות דיין להגיב לשינויים זמניים או קבועים באזור או באקלים הפוליטי, מאחר שאלה וגורמים אחרים משפיעים על סוגי מצבי החירום ועל דרך הטיפול.

חשיבותה של מערכת רפואת חירום היא בתרומתה לתושבים ולמערכת הבריאות במדינה, והיא המעגל הראשון של הטיפול הרפואי. היא מעניקה טיפול רפואי ראשוני וחיוני, לרוב עד כדי הצלת חיים ומניעת סיבוכים ונכויות. אין זה ברור איזו משתי השיטות היא הטובה ביותר להשגת מטרה זו שכן היא תלויה בגורמים רבים: פוליטיים, אזוריים, כלכליים ותרבותיים. כיום מקובלות לצד שתי השיטות העיקריות האלה גם שיטות המורכבות משילוב בין השתיים.

מרכיבי מערכת רפואת חירום טרום־אשפוזית

גוף שמעניק רפואת חירום טרום־אשפוזית צריך להכשיר את הציבור הרחב וללמדו לזהות מצבים מסכני חיים, למנוע אותם ולהגיש עזרה ראשונה בסיסית לנפגעים. לכן, מרבית השירותים יכללו מחלקת הדרכה המבוססת על צוותים בעלי ניסיון רב באבחון מצבי חירום ובטיפול בהם. צוותים אלה מגיעים בדרך כלל אל הציבור הרחב ומעבירים לו בהשתלמויות ובקורסים את הידע והניסיון שצברו. באמצעות חינוך האוכלוסייה יפחת מספר המקרים הדורשים את התערבות מערך רפואת החירום, והציבור ידע כיצד להזעיק את השירות בעת הצורך ואיך להתחיל להגיש עזרה ראשונה בסיסית. לצורך הזנקת שירותי רפואת החירום פותחו כמה יישומונים ייעודיים (אפליקציות). יישומונים אלו מאפשרים שידור מיידי של מקום המתקשר אל תוכנת השליטה והבקרה במוקד. יש יישומונים שבהם אפשר לנהל שיחות וידאו מתקדמות, להעלות נתונים רפואיים של המטופל כולל סיכומי מחלה, תרשים אק"ג, אלרגיות, נשיאת מזרק אפינן או משאף ונטולין, פרטים על מושלתי קוצב או חולי סוכרת ועוד. באמצעות היישומון אפשר להעביר מידע מהיר ואמין אל מוקד שירותי רפואת החירום ובכך לקצר ולייעל את זמן המענה ואת איכות הטיפול שיקבל הנפגע. גם במד"א פותח יישומון שבאמצעותו אפשר להעלות נתונים רפואיים רבים, סיכומי מחלה, תרופות מיוחדות, רגישויות, פרטים על חולי לב וחולי סוכרת ועוד.

החלק השני של המערכת הוא המוקד הטלפוני. אל המוקד הטלפוני אפשר להגיע באמצעות חיוג מספר מקוצר (בישראל 101, בארה"ב וקנדה 911, באירופה 112 וכדומה בכל העולם). השיחה למספר מקוצר זה אינה כרוכה בתשלום. תורן המוקד מפעיל מערכת מחשוב משוכללת המאפשרת במקרים רבים לזהות את מקום המתקשר, להציג נתונים על אופי האירוע ולהציג נתונים על המטופל אם הזנו מראש למערכת או כשמדובר במטופלים חוזרים. מערכות משוכללות יכולות לקבל נתונים גם באמצעות שיחת וידאו או סרטון, תמונות, טקסט ועוד. כמה מהמערכות מאפשרות תרגום מיידי של שיחות או הודעות טקסט במגוון שפות. עם קבלת הקריאה במוקד הטלפוני מוזנים כל הפרטים למערכת שליטה ובקרה. נתונים אלו מועברים למשגרי הצוותים, ובמערכות מתקדמות הם מועברים ישירות לצוות המטפל הנמצא כבר באמבולנס בדרכו לאירוע. מידע זה מועבר באמצעות מערכות ממוחשבות ובמכשירים הסלולריים שברשות הצוות.

מידע עם קבלת פרטי האירוע, ובזמן שהצוות הרפואי נמצא בדרכו אל המטופל, תורן המוקד נותן למתקשר הנחיות למתן עזרה ראשונה בסיסית לנפגע. הנחיות אלו ניתנות על פי פרוטוקולים רפואיים המותאמים להנחיות טלפוניות. במקרים רבים יבקש תורן המוקד מהמתקשר לצלם את הנפגע או את אופן מתן הטיפול כדי לוודא שהטיפול שמוענק מתאים ונכון.

את הטיפול הרפואי יעניקו אנשי צוות מיומנים בכמה שלבים. השלב המיידי יהיה על ידי מגיבים ראשוניים. נוסף על עוברי האורח יש מתנדבים שהוכשרו במיוחד למטרה זו. מתנדבים אלו פרוסים בכל המרחב הגאוגרפי של נותן השירות. הם מגיעים לזירת האירוע ברכבם הפרטי, באופנוע ייעודי או באופניים. מגיבים ראשוניים יכולים להיות גם צוותי כבאות ומשטרה שפועלים בשיתוף עם שירותי רפואת החירום הטרם־אשפוזית. אלו יגיעו בתוך דקות ספורות אל המקום שנמסר להם על ידי המוקד, ויחלו במתן טיפול רפואי ראשוני עם הציוד הנמצא ברשותם ועל פי הסמכתם והכשרתם, עד להגעת צוות רפואת החירום.

כחלק ממערך המגיבים הראשוניים נחנך במד"א ב־2016 פרויקט "נאמני חיים", ובמסגרתו גויסו יותר מ־17,000 בני אדם ברחבי הארץ. הם עברו הכשרה להגשת עזרה ראשונה בסיסית, ויכולים לסייע בהצלת חיים עד להגעת האמבולנס. מערכת איתור מיוחדת, הפועלת באמצעות יישומון, מאתרת את כל נאמני החיים שנמצאים במרחק דקות ספורות מהמקום שבו דווח למוקד מד"א על חולה שנזקק להחייאה, ומזניקה אותם. זאת במקביל להזנקת צוותי מגן דוד אדום ולהדרכה הטלפונית הניתנת על ידי החובשים והפראמדיקים במוקד 101 של מד"א.

שירותי רפואת החירום ניתנים לרוב באמבולנסים. כיום יש במרבית השירותים אמבולנסים בשתי רמות של שירות לפחות: אמבולנסים להגשת עזרה ראשונה וניידות לטיפול נמרץ (נט"ן). האמבולנסים להגשת עזרה ראשונה מצוידים בצידוד החייאה למבוגרים, ילדים ותינוקות, כולל מכשיר דפיברילטור למתן שוק חשמלי, מכשור להעשרה בחמצן, ציוד עזרה ראשונה וחבישה, ערכת לידה וציוד נשיאה לפינוי הנפגע לבית החולים. הם מופעלים על ידי חובשים וחובשים בכירים.

הניידות לטיפול נמרץ מצוידות בצידוד החייאה מתקדם הכולל מכשור רפואי בסיסי ומתקדם לפתיחת נתיב אוויר, מכשיר הנשמה אוטומטי ואפשרות להנשמה בלחץ חיובי, ניטור קצב הלב וביצוע אק"ג, מתן שוק חשמלי, קיצוב לב חיצוני, פרוצדורות כירורגיות (ניתוחים) בסיסיות, מתן נוזלים ותרופות החייאה ועוד. הניידות לטיפול נמרץ מופעלות על ידי רופאים, אחיות ופראמדיקים המוסמכים לכך. במקומות שונים בעולם הסמכות של הצוות הרפואי שונה וכן הפרוצדורות שהם רשאים לבצע במקום האירוע. האמבולנסים והניידות לטיפול נמרץ מיועדים להעביר את המטופלים אל בתי החולים הייעודיים לפי סוג האירוע. כיום יש אמבולנסים מסוגים חדשים כגון: סירות ים, רכבי שטח מתקדמים, מסוקים, מטוסים ואף אמבולנסים ייעודיים עם מכשירי דימות ומכשירי "לב-ריאות" המאפשרים לתת טיפול מתקדם במגוון זירות אירוע.

חלק מהארגונים המעניקים שירותי רפואת חירום טרום־אשפוזית מפעילים מערך מרפאות ראשוניות למתן עזרה ראשונה וטיפול רפואי בסיסי. מרפאות אלו פועלות בדרך כלל בשעות ששירותי הרפואה הקהילתית אינם זמינים. נוסף על כך, חלק מהשירותים מפעילים אמבולנסים למתן טיפול בית לחולים כרוניים וכן רפואה ראשונית הכוללת בדיקות מעבדה, טיפול רפואי וטיפול תומך למטופלים מרותקים ובמסגרת אשפוזי בית. שירותים אלו מאפשרים להשאיר מטופלים אלו בביתם לאחר הטיפול, ללא פינוי לבית חולים.

המטופלים של שירותי רפואת חירום טרום־אשפוזית

שירותי רפואת החירום הטרם־אשפוזיים מטפלים בחולים ובפצועים. גורם המוות העיקרי בצעירים עד גיל 44 הוא טראומה הנגרמת מתאונות, מאלימות, ממלחמות, מניסיונות התאבדות וכדומה. אצל אנשים בני 45 ומעלה רוב מקרי המוות נגרמים ממחלות לב וכלי דם הגורמות לאוטם שריר הלב, להפרעות חמורות בקצב הלב ולשבץ מוחי. גורמים נוספים למוות הם מחלות נשימה חסימתיות שהולכות ומתגברות ככל שזיהום האוויר מחמיר. סיבה נפוצה נוספת היא מחלות ממאירות.

שירותי רפואת חירום טרום־אשפוזית חיוניים בכל המקרים שבהם ביכולתם להשפיע לטובה על מצבו של המטופל כמו במקרים של מחלות לב או טראומה ולא במקרים של מחלות ממאירות. המטרה העיקרית של השירותים היא למנוע תמותה אך לא פחות מכך למנוע נכות וסיבוכים. לכן במקרים רבים יוזנקו האמבולנסים לטיפול גם בחולים ובנפגעים שאינם בסכנת חיים מיידיה, דוגמת מטופלים החולים במחלות זיהומיות, מטופלים עם סיבוכים של מחלות כרוניות וכן במקרים שבהם כדי להעביר את האדם לאשפוז יש צורך להשתמש באמצעי הנשיאה וההעברה שבהם מצוידים האמבולנסים.

למרות התפוצה הרחבה והפריסה המצוינת של שירותי רפואת החירום הטרם־אשפוזית בעולם, עדיין במקרים רבים שבהם נשקפת לאדם סכנת מוות ובהם שירותי רפואת החירום יכולים לסייע - הם אינם מוזנקים בשל חוסר מודעות החולה למצבו או בשל שיקולים כספיים. כ־50% ממקרי אוטם שריר הלב בישראל מגיעים בכוחות עצמם לחדר המיון. גם במקרי חירום רפואיים בילדים מעטים מגיעים לבית החולים באמצעות שירותי רפואת החירום. מרבית הילדים מובאים לבית החולים על ידי הוריהם. אך חשוב להדגיש כי בשתי הדוגמאות האלה יש ערך רב לטיפול מוקדם, להודעה מוקדמת לבית החולים ולפינוי מהיר לבית החולים. במקרי אוטם שריר

הלב, ביצוע אק"ג על ידי ניידת טיפול נמרץ יוביל את המטופל ישירות לחדר צנתורים בלי להתעכב בחדר המיון. בילדים, מחלות בדרכי הנשימה, מחלות זיהומיות ואחרות הן גורם עיקרי לתחלואה, ופעמים רבות יש צורך בטיפול בחמצן הקיים באמבולנסים. יוצא מכך שלמרות התועלת הרבה שיש לשירותי רפואת חירום לאנשים צעירים ולילדים, הציבור שמשתמש בשירותי רפואת החירום הטרום-אשפוזית באופן הנרחב ביותר הוא מבוגרים (בני 75 ומעלה) עם מחלות כרוניות הנפוצות בגיל זה, ואחד המאפיינים שלהם הוא יכולת ניידות מוגבלת.

טיפול טוב יותר בשלב טרום-בית החולים עשוי להוביל לאוכלוסייה בריאה יותר ולצמצם את הוצאות הטיפול בשלב טרום-בית החולים ובבית החולים עצמו.

הכפיפות החוקית של מערך רפואת חירום טרום-אשפוזית

במדינות רבות מופעלים מערכי רפואת חירום טרום-אשפוזית על ידי הממשלה, והם כפופים למשרדי הבריאות או ביטחון הפנים. בכמה מהן מופעלים השירותים על ידי תאגידים, ארגונים וולונטריים או ארגונים פרטיים. בכל המקרים האלה יש רשות לאומית מובילה המתכננת ומבקרת את פעילות מערכי החירום. תחומי האחריות של הרשות כוללים פיתוח, חקיקה, פיקוח ובקרה, ארגון של המערכת ולעיתים גם מימון. בדרך כלל כדי להפעיל מערך רפואת חירום טרום-אשפוזי יש צורך בתמיכה ובמשאבים המגיעים מהממשלה או מהרשות המקומית. גם אם הפעילות מבוססת על ארגון פרטי למטרות רווח, לעיתים הוא יהיה קשור במרכז לאספקת השירותים עם העיר או המדינה. בדרך כלל שירותי רפואת החירום מבוססים על אזור גאוגרפי מסוים, כגון רשות מקומית או אזורית או בפריסה ארצית.

החוקים המסדירים את שירותי רפואת החירום הטרום-אשפוזית

על שירותי רפואת חירום טרום-אשפוזית לעמוד בתקנים שאותם מגדירה המדינה והם הבסיס החוקי להפעלת השירות. חשוב ששירותי רפואת חירום טרום-אשפוזית יעמוד ברמה המקצועית הנדרשת ממנו, וכמו כן מוטל על הארגון לנהל את התהליכים ואת משאבי האנוש. בראש ובראשונה, החוקים מגדירים מהו ארגון רפואת חירום טרום-אשפוזית, מי הם הגורמים המכשירים, המסמיכים והמורשים לספק שירותי רפואת חירום טרום-אשפוזית, מי מספק הכוונה רפואית ומהן הדרישות המינימליות מארגון כזה. חוקים אלו כוללים גם הנחיות המפרטות את הפעולות הננקטות אם יש חריגה מחוקים ומנהלים אלו. כמו כן, החוקים מגדירים את דרכי ההתקשרות עם הארגון, ובייחוד את מספר החיוג המקוצר למוקד החירום, וכן דרכי תקשורת בתוך הארגון ודרכי תקשורת עם ארגוני חירום אחרים. כמו כן, החוקים מייעדים מתקנים רפואיים, כמו תחנות ונקודות הזנקה, מוקדים ומרכזי טיפול מיוחדים במידת הצורך.

החוקים מפרטים מהם האזורים שבהם ניתנים השירותים ובאילו מקרים על ארגונים שונים לשתף פעולה ולסייע זה לזה. עוד מפרטים החוקים את תחומי האחריות ואת ההרשאות של כל ארגון.

נוסף על אלו יש חוקים מקצועיים, ואלו קובעים את היקף ההתמחות, את הכישורים הנדרשים מכל ארגון ואת התנאים שבהם מותר להם להעניק את השירות. נוסף על כך, החוקים קובעים את רמות ההכשרה והיקפיהן, את המיומנויות הנדרשות מן הצוות הרפואי, את היקף וסמכויות ההכוונה הרפואית המותרת וכן הנחיות לגבי היעדים שאליהם מפנים את המטופלים, הנחיות לביצוע מיון ראשוני, קביעת סדרי עדיפויות ופרוטוקולים להעברה בין מתקנים. חוקים מקצועיים נוספים קובעים מהו הציוד הרפואי המינימלי הנדרש, מהם סוגי הציוד המורשים לשימוש, סוגי כלי רכב, אמצעי תקשורת ועוד.

חוקים ארגוניים ומנהליים קובעים הוראות עבור זמן התגובה, פריסת רכבי ההצלה, חריגות משמעת, תגובות לחריגה מחוקים ונהלים, נהלי חקירת תלונות, תהליכים לשיפור איכות השירות וקביעת מקורות מימון קבועים כגון: גביית תשלום עבור שירותים, מימון ממשלתי ומימון ציבורי וכן מקורות מימון מזדמנים, כגון תרומות וקניית שירותים. הגדרות חשובות נוספות הנובעות מהחוקים הן דרכי איסוף נתונים, דיווח ושמירה על סודיות רפואית. המסקנה היא כי שירותי רפואת החירום נדרשים לעמוד בתקנים מחמירים ובביקורת מתמדת כדי למלא את משימתם ולעמוד בסטנדרטים העדכניים ביותר בתחום.

קביעת האופי הרפואי של השירות

ברחבי העולם מקובל שנוסף על מערכת החוקים והתקנות המעניקה סמכות לארגוני רפואת חירום טרום-אשפוזית להעניק שירותים, יש חשיבות להכוונה רפואית מקצועית. מערך רפואת חירום טרום-אשפוזית, ובפרט אם הוא מופעל על ידי פראמדיקים, אחיות או חובשים ללא נוכחות רופא, זקוק להכוונה רפואית על ידי מנהל רפואי המתווה את הטיפול המקובלים וגבולותיהם, את סמכויות אנשי הצוות ואת רמות הכשרתם וכן יוזמות רפואיות לשיפור איכות הטיפול.

רופא השירות הוא הסמכות המקצועית המסמיכה את אנשי הצוות הרפואי בכל הרמות, והוא גם זה שאחראי כלפי הרשויות על מתן השירות ברמה המקצועית הנדרשת. בדרך כלל השירות הרפואי תואם את הרמה המקצועית הנהוגה במדינה ובפרט בחדרי המיון המקבלים את המטופלים והנפגעים משירותי רפואת החירום. ללא התאמה בין רמת הטיפול הניתנת באמבולנסים ובין רמת הטיפול בחדר המיון, הטיפול במערך רפואת החירום לא ישפר את מצבו של המטופל, ורמה נמוכה של טיפול לא תאפשר הגעתו במצב מניח את הדעת לבית החולים.

לשם מתן השירות הרפואי מתבסס השירות על פרוטוקולים רפואיים. עקרונות הפרוטוקולים מונחים על ידי הממשלה לפי דרישות הממשלה ולפי המשאבים שיש בארגון. הפועל היוצא מהפרוטוקולים הרפואיים הוא רמת הכשרת הצוותים והציוד הנדרש למימושם. רמת הצוותים נחלקת בדרך כלל לשתיים - צוותי רפואת חירום בסיסיים (BLS) - ובהם בעיקר חובשים ומתנדבים, והרמה השנייה - צוותי רפואת חירום מתקדמים (ALS) ובהם רופאים ופראמדיקים. אלה וגם אלה חייבים לדעת היטב לפעול על פי הפרוטוקולים הרפואיים, ועל פיהם בנויים קורסי ההכשרה שלהם כדי לבסס את הטיפול הרפואי על הידע והמימוניות הנדרשים.

רפואת חירום פועלת בתרחישים שונים ובזירות אירוע מרוחקות זו מזו. לכן, איכות הטיפול מורכבת, הן מאמינות גבוהה של אנשי הצוות והן מבקרה הדוקה על פעילותם. מעצם טבעו השירות עוסק בדקות הקריטיות ביותר להצלת חייו של המטופל, ולכן תחקיר ובקרה בדיעבד בלבד אינם יכולים לתת מענה למקרים אלו. מערכת רפואת חירום טרום-אשפוזית חייבת להפעיל מערך בקרה בזמן אמת הן באמצעות טכנולוגיה מתקדמת והן באמצעות בקרה פיזית על ידי מפקחים.

מימון המערכת

כמו במערכת הבריאות הכללית, גם מערכי רפואת חירום טרום-אשפוזית בעולם ממומנים על ידי מגוון רחב של מקורות. ברוב ארצות העולם הארגונים הממומנים על ידי הממשלה בדרך כלל אינם גובים תשלום עבור השירות או גובים תשלום נמוך מאוד. ממשלה המספקת את שירותי רפואת החירום אינה יכולה להצדיק גביית תשלום ריאלי על ידי אנשים במצבי חירום הנזקקים לשירותי הצלת חיים.

במדינות שבהן יש מערכות פרטיות למטרת רווח, אלו בדרך כלל מערכות יעילות מבחינה תפקודית אולם מחיר השירות גבוה. כדי למנוע את השחיקה המקצועית של השירות הניתן על ידי ארגונים פרטיים נדרשות אמות מידה ציבוריות המפוקחות על ידי הממשלה.

שירות הניתן על ידי ארגוני מתנדבים, דוגמת הצלב האדום, חייב להיות ברמה מקצועית גבוהה לא פחות מהשירות הניתן על ידי הארגונים הממשלתיים. היתרון היחסי של שירות שכזה הוא המחיר הנמוך שנדרש הלקוח לשלם עבור השירות. חיסרון אפשרי של שירות התנדבותי הוא שלא יהיו לו די משאבים לתת את השירות במלואו. התבססות על מתנדבים בלבד יכולה לפגום בזמינות הצוותים בשעות מסוימות ביממה ובתקופות שונות בשנה. במקומות רבים בעולם יש מגוון ארגונים ובהם, לצד שירות פרטי או ציבורי המופעל על ידי בית החולים ושירותי חירום עירוניים או ממשלתיים, יש גם ארגוני רפואת חירום התנדבותיים שעיקר הטיפול שהם נותנים הוא העברת מטופלים בין בתי חולים ומוכנות לשעת חירום.

מגן דוד אדום - ארגון רפואת החירום הטרומ־אשפוזית של ישראל

מגן דוד אדום (מד"א) הוא הארגון הלאומי להצלה ולשירותי דם של ישראל. הוא מוגדר כארגון חירום טרומ־אשפוזי. על פי חוק מגן דוד אדום, תשי"ז-1950, מד"א הוא אגודה ארצית שתפקידה בישראל הוא מתן שירותי עזרה ראשונה, התרמה ואגירת דם, והיא ממלאת בישראל את תפקידי אגודת הצלב האדום על פי אמנת ז'נבה. הארגון חרט על דגלו את האמרה התלמודית: "כל המקיים נפש אחת מישראל, כאילו קיים עולם מלא" שהגדירה את ייעודו המרכזי מיום היווסדו ועד היום: הצלת חיי אדם באמצעות רוח התנדבות ומחויבות של אלפי מתנדבים ועובדים הרואים בהגשמת הייעוד ערך נעלה ומשקיעים מעל ומעבר להגשמתו.



תמונה 1.1 לוגו של מגן דוד אדום:
ארגון ההצלה של מדינת ישראל

מגן דוד אדום הוא חלק מההיסטוריה של מדינת ישראל והוא חלק בלתי נפרד מן ההווה הישראלית. זה 90 שנה משרת מד"א בנאמנות את תושבי מדינת ישראל בשגרה ובעיתות חירום לאומיות בכל הנושאים העיקריים הנובעים מהערך הנעלה של קיום נפש בישראל: הגשת עזרה ראשונה ורפואת חירום טרומ־אשפוזית, הן בסיסית והן מתקדמת, הנחלת הידע בתחום זה לציבור הרחב ולמערכת הרפואה באמצעות קורסים, הדרכות והכשרות מקצועיות, התרמת דם ואספקתו לבתי החולים ופעילות הומניטרית למען נזקקים.

בכל 38 שניות בממוצע מוזנק צוות מד"א לאירוע חירום, החל מהתקף לב או תאונת דרכים ועד ליולדת בתהליך לידה. מתחנה קטנה בתל אביב ובה אמבולנס יחיד, הפך מד"א לארגון ראשון במעלה בעולם בתחום רפואת החירום ולו 180 תחנות הזנקה בכל רחבי הארץ, כ־1,200 אמבולנסים, ניידות טיפול נמרץ, מסוקים, סירות ואופנועים לטיפול חירום המאוישים בצוותים מקצועיים שמגישים טיפול חירום רפואי לכל תושבי המדינה ללא הבדלי דת, גזע מין ולאום. למד"א מגיעות כ־800,000 קריאות בשנה בממוצע והוא אוסף כ־265,000 מנות דם בשנה באמצעות בנק הדם הלאומי.

מתנדבים הם שהקימו את מד"א והיו פעילים בו מראשיתו. כיום מונה מערך המתנדבים מעל 40,000 אנשי צוות ובהם: חובשים, פראמדיקים, רופאים, מתנדבי נוער ונאמני חיים. נאמני חיים הם כונני תגובה שיש ברכבם הפרטי